

感染症による登園基準表 平成27年4月～

保育所 和光園

登園には、『学校感染症等に係る登校・登園に関する意見書』の提出が必要となります。用紙は入園のしおり使用するか、事務所にお声がけください。

病名	潜伏期間	感染しやすい時期	主な症状	登園基準
1 インフルエンザ	1～3日	感染後約10日	発熱、全身倦怠、筋肉痛、咽頭痛、咳	発熱後5日から解熱した後3日が経過し、全身状態が良好
2 百日咳	7～10日	感染後約3週	発熱性傾向の長期反復、持続	特有の咳が消失したとき
3 はしか（麻疹）	10～12日	発疹出現の前夜4～5日	発熱、目やに、結膜充血、コプリック斑→発疹	発疹に伴う熱が下がった後、3日経過してから
4 おたふくかぜ （流行性耳下腺炎）	15～21日	明確な症状を示す7日前からそのあと9日続く	発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の腫れ及び圧痛	耳下腺の腫れが消失したとき
5 三日はしか（風疹）	14～21日	発疹出現の前夜7日	顔面→頸部→体幹→四肢への発疹、軽熱、リンパ節腫脹	発疹が消失したとき
6 水ぼうそう（水痘）	14～21日	水泡出現前2～6日	発熱、発疹、斑丘疹移行→水泡→顆粒状血皮	すべての発疹がかさぶたになったとき
7 ブール熱 （咽頭結膜熱）	5～7日	潜伏期後半～発症後約5日間	発熱、全身症状、咽頭炎と結膜炎の合併症	解熱し、主要症状がなくなった後、2日を経過してから
8 流行性結膜炎	5～12日	発症後約2週間	咽頭炎と結膜炎の炎症、リンパ節腫、目やに	治癒するまで
9 急性出血性結膜炎	1～2日	発症後約4日	流涙、結膜充血、眼瞼浮腫、涙分泌	治癒するまで
10 ヘルパンギーナ	2～7日	1週間	高熱、咽頭痛、咽頭に水泡	解熱した後、食事も十分にできるようになったとき
11 猩紅熱 （伝染性紅斑）	7～10日	14～20日	顔面赤斑とくに頸部の赤斑性発疹	発疹出現時は感染力が少なくなっているため、元気がよければ登園可
12 溶連菌感染症	2～7日	抗菌薬内服後24時間が経過するまで	発熱、咽頭痛、扁桃腺炎、葡萄舌、頸部リンパ節炎、全身に発疹	（有効治療をはじめて2～3日たって）
13 乳児嚔下下痢症 感染性胃腸炎	不定期	感染後1週間 （主に口、ノド、アデノ）	発熱、腹痛、下痢、嘔吐、脱水	主症状がほぼ消失し、医師が登園を認めたとき
14 R Sウイルス感染症	2～8日	乳児は3～4週間	発熱、咳、喘息、呼吸困難	重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良好
15 マイコプラズマ感染症	14～21日	症状発現から4～6週間	咳、発熱、呼吸困難、鼻汁、食欲低下	症状が改善し、元気があれば登園可能
16 突発性発疹	10～15日	発熱中	発熱、解熱とともに全身に発疹	主な症状がほぼ消失し、医師が登園を認めたとき
17 ヘルペス口内炎	3～7日	水泡を形成している間	口内炎症	症状が改善し、食事が十分に取れる
18 帯状疱疹			水ぼうそう（水痘）に準ずる	

※下記については、登園不可にはなりませんが、感染力が高いため、症状によって水遊びを制限する等、集団保育の場として十分配慮が必要です。

とびひ （伝染性膿痂疹）	5～10日	水泡消滅まで	主として豆粒大の水泡自覚症状（あまりなし）	kannse
水いぼ （伝染性軟属腫）	14～50日		球状のいぼ	皮膚・粘膜が湿潤している間は、接触感染する。
手足口病	2～7日	水泡消滅まで	感冒様症状、手足口に赤斑→水泡	化膿・悪化していない場合は、プール入水可能。 悪化すると、治療の際に激しい痛みを伴う。

※朝、必ず検温し、健康調べ表に記入してください。37.5度以上熱があるときは登園できません。

保育をしている途中で37.5度以上の発熱が認められた時は、保護者に連絡しますので、お迎えをお願いします。

※上記感染症以外でも、園の判断により登園許可書やお休みをお願いする場合があります。あらかじめ、ご理解のほどをお願いします。

※大きなけがや緊急を要するときは保護者、看護師に処置や指示を受け対応します。